

OFFLABEL-INDICATIES BIJ BLAASCARCINOOM, PROSTAATCARCINOOM EN TESTISCARCINOOM

Niet alle studies bij blaascarcinoom te beoordelen met de PASKWIL-criteria

Voor sommige offlabel-indicaties van oncologische geneesmiddelen is (nog) geen vergoeding geregeld. De NVMO inventariseert deze indicaties om vervolgens in overleg met Zorgverzekeraars Nederland ook voor deze indicaties tot een vergoeding te komen. Internist-oncoloog prof. dr. Ronald de Wit buigt zich over de situatie bij prostaatcarcinoom, blaascarcinoom en testiscarcinoom.

‘De belangrijkste verandering bij prostaatcarcinoom ten opzichte van de *NVMO-consensustekst indicaties oncologische middelen* uit 2016 is dat tegenwoordig ook mannen met gemetastaseerd prostaatcarcinoom bij diagnose, dus hormoontherapienaïef, in aanmerking kunnen komen voor de toevoeging van docetaxel of van abirateron plus prednison aan de androgeendeprivatietherapie’, steekt De Wit van wal. ‘Respectievelijk de CHAARTED-studie¹, de STAMPEDE-studie²⁻³ en de LATITUDE-studie⁴ hebben aangetoond dat het toevoegen van respectievelijk docetaxel en abirateron plus prednison leiden tot een significante winst ten aanzien van zowel de progressievrije als totale overleving. De afgelopen jaren gaf de NVMO-commissie BOM ook over deze indicaties een positief advies.’

Een formeel punt is dat er voor deze indicatie van docetaxel nooit bij de EMA een officiële registratie is aangevraagd. Dit vanwege het feit dat docetaxel al uit patent was en daardoor zeer goedkoop. Formeel is dit dus een offlabel-indicatie. De NVMO heeft voor deze indicatie onlangs bij Zorgverzekeraars Nederland de vergoeding geregeld (ID 1591).

Blaascarcinoom

‘Op het gebied van de systemische behandeling van blaascarcinoom ofwel urotheelcarcinoom heeft na het verschijnen van de NVMO-consensustekst in 2016 immuuntherapie haar intrede gedaan’, vervolgt De Wit. ‘De KEYNOTE-045-studie heeft aangetoond dat bij patiënten met niet-resectabel of gemetastaseerd urotheelcarcinoom, na platina-bevattende chemotherapie, een behandeling met pembrolizumab leidt tot een significant langere totale overleving vergeleken met een tweedelijns behandeling met chemotherapie.⁵ De behandeling met pembrolizumab gaat bovendien gepaard met minder toxiciteit en resulteert daardoor in een betere kwaliteit van leven.⁶ Overigens kan worden gesteld dat buiten studieverband tweedelijns chemotherapie bij blaascarcinoom met middelen als vinflunine, docetaxel en paclitaxel wegens geringe effectiviteit – een responskans van minder dan 10 procent – geen plaats heeft. Op basis van de resultaten van de KEYNOTE-045-studie is deze tweedelijns behandeling met pembrolizumab door de EMA goedgekeurd en ook door de commissie



Prof. dr. R. de Wit is internist-oncoloog aan het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam, hoogleraar Experimentele systeemtherapie van urogenitale tumoren en voorzitter van de Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS).

BOM van een positief advies voorzien.’
‘Daarnaast zijn ook de checkpointinhibitoren nivolumab en atezolizumab door de EMA goedgekeurd als tweedelijns behandeling bij patiënten met niet-resectabel of gemetastaseerd urotheelcarcinoom na platinabevattende chemotherapie. Aangezien deze goedkeuring op de resultaten van niet-gerandomiseerde fase II-studies⁷⁻⁸ berust, heeft de commissie BOM hierover geen uitspraak kunnen doen. Pembrolizumab en atezolizumab zijn eveneens door de EMA goedgekeurd als eerstelijns behandeling bij patiënten met gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom die een contra-indicatie hebben voor eerstelijns behandeling met platinabevattende chemotherapie. Deze goedkeuring is verkregen op basis van resultaten uit de KEYNOTE-052 studie⁹ en de IMvigor21-studie¹⁰. Dit betreffen echter ook niet-gerandomiseerde fase II-studies, waardoor de commissie BOM hierover geen uitspraak kan doen.’ Inmiddels heeft de EMA een restrictie uitgesproken voor de behandeling met pembrolizumab of atezolizumab in de eerste lijn: alleen patiënten bij wie de PD-L1-kleuring positief is, komen nu nog in aanmerking voor deze behandeling. Bij een negatieve PD-L1-kleuring blijft eerstelijns behandeling bij patiënten die geen cisplatine kunnen krijgen de combinatie carboplatine plus gemcitabine de eerste keuze.

Testiscarcinoom

‘Ten aanzien van de behandeling van testiscarcinoom en extragonadale kiemceltumoren is er niets veranderd ten opzichte van de consensustekst van 2016’, merkt De Wit op. ‘Dat is ook niet zo vreemd, want dit zijn zeer weinig voorkomende vormen van kanker waarvoor de afgelopen jaren geen nieuwe studieresultaten beschikbaar zijn gekomen. De middelen die in de vorige consensustekst worden genoemd als tweedelijns behandeling – oxaliplatine, ifosfamide, paclitaxel en gemcitabine – zijn nog steeds in gebruik zonder dat daar een officiële indicatie voor is. Het zijn dus formeel offlabel-indicaties.’ Daarbij geldt overigens dat voor paclitaxel, gemcitabine en oxaliplatine de vergoeding is geregeld, terwijl ifosfamide binnen de DOT wordt vergoed. ←

‘Er kan worden gesteld dat buiten studieverband tweedelijns chemotherapie bij blaascarcinoom met middelen als vinflunine, docetaxel en paclitaxel wegens geringe effectiviteit geen plaats heeft’

Referenties

- Sweeney CJ, Chen YH, Carducci M, et al. Chemohormonal therapy in metastatic hormone-sensitive prostate cancer. *N Engl J Med* 2015;373(8):737-46.
- James ND, Sydes MR, Clarke NW, et al; STAMPEDE investigators. Addition of docetaxel, zoledronic acid, or both to first-line long-term hormone therapy in prostate cancer (STAMPEDE): survival results from an adaptive, multiarm, multistage, platform randomised controlled trial. *Lancet* 2016;387(10024):1163-77.
- James ND, de Bono JS, Speras MR, et al; STAMPEDE Investigators. Abiraterone for prostate cancer not previously treated with hormone therapy. *N Engl J Med* 2017;377(4):338-51.
- Fizazi K, Tran N, Fein L, et al; LATITUDE Investigators. Abiraterone plus prednisone in metastatic, castration-sensitive prostate cancer. *N Engl J Med* 2017;377(4):352-60.
- Bellmunt J, de Wit R, Vaughn DJ, et al; KEYNOTE-045 Investigators. Pembrolizumab as second-line therapy for advanced urothelial carcinoma. *N Engl J Med* 2017;376(11):1015-26.
- Vaughn DJ, Bellmunt J, Fradet Y, et al. Health-related quality-of-life analysis from KEYNOTE-045: a phase III study of pembrolizumab versus chemotherapy for previously treated advanced urothelial cancer. *J Clin Oncol* 2018;36(16):1579-87.
- Rosenberg JE, Hoffman-Censits J, Powles T, et al. Atezolizumab in patients with locally advanced and metastatic urothelial carcinoma who have progressed following treatment with platinum-based chemotherapy: a single arm, phase 2 trial. *Lancet* 2016;387(10031):1909-20.
- Sharma P, Retz M, Siefker-Radtke A, et al. Nivolumab in metastatic urothelial carcinoma after platinum therapy (Checkmate 275): a multicentre, single-arm, phase 2 trial. *Lancet Oncol* 2017;18(3):312-22.
- Balar AV, Castellano D, O'Donnell PH, et al. First-line pembrolizumab in cisplatin-ineligible patients with locally advanced and unresectable or metastatic urothelial cancer (KEYNOTE-052): a multicentre, single-arm, phase 2 study. *Lancet Oncol* 2017;18(11):1483-92.
- Balar AV, Galsky MD, Rosenberg JE, et al; IMvigor210 Study Group. Atezolizumab as first-line treatment in cisplatin-ineligible patients with locally advanced and metastatic urothelial carcinoma: a single-arm, multicentre, phase 2 trial. *Lancet* 2017;389(10064):67-76.